

INDICADO POR: Dr^a Roberta

X ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

JEAN HENRIQUE ESCUDERO PRINCE DA SILVA

IDADE: 33 PESO: 100 ALTURA: 172 PROFISSÃO: Agressor Vereador.

SINTOMAS: Sonolência Diurna / Dor de cabeça a noite / RGE / Boca seca / muito saliva durante o sono

QUEIXAS: Cansaço - Mal humor

MEDICAMENTOS: Reconten / conceuter (TDH) (↓ testosterona)

MÉDICO: Dr^a Roberta

MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N

EXERCÍCIO FÍSICO: academia 3X

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: (N) (10h) ALMOÇO: 12 LANCHE: N JANTAR: 5

HORA QUE DORME: 23 HORA QUE ACORDA: 06:45

COCHILO (X) S () N ^{aviso} DORME ACOMPANHADO: (X) S () N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: () S (X) N / DORMEM NO QUARTO: () S (X) N PET NO QUARTO: () S (X) N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA (X) N

FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO/NOITE: 3x 4x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: elevado CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: IAH: SPO2:

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: nega

CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (V) RESPIRATÓRIA (X) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA ^{esquerdo}(S) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS: ^{por lombar}

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S (X) N SPO2 C/ CPAP: — PRESSÃO NO EXAME: —

13/05 Avaliação
26

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA BASAL

Nome: JEAN HENRIQUE ESCUDERO PRINCE DA SILVA
Data do Exame: 20-12-2025
Peso: 98 kg
Médico Solicitante: DR. ENIO NAKUHIRO KOKUBU

Sexo: Masculino
Idade: 33 anos
Altura: 1,72 m

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 20/12/2025 22:11 e finalizado às 21/12/2025 05:44.
A latência para início do sono foi de **95,5 min** e a latência para o sono REM de **81,0 min**.
O tempo total de sono (TTS) foi de 292,5 min, com eficiência do sono de **64,5 %**.
A distribuição dos estágios do sono mostrou **3,6 %** de estágio N1, **55,0 %** de estágio N2, **11,8 %** de estágio N3 e **29,6 %** de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 65,2 min. Ocorreram 44 despertares, sendo o índice de **5,8 (nº/h)**.

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de **0,0 (nº/h)**, 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 195, sendo 34 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 161 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de **40,0 (nº/h)**. O IDR durante o sono REM foi de 32,6 e o IDR durante o sono NREM foi de 43,1. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 40,0 (nº/h), sendo 7,0 apneia/h e 33,0 hipopneia/h.

A saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂) basal foi 91%, a média de 91% e a mínima de 82%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (IDO) foi de 20,1 (nº/h), sendo que em REM foi de 25,7 (nº/h) e em NREM foi de 32,6 (nº/h). Permaneceu 8,8 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (16), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório (**40,0 nº/h**) (VN= até 5 nº/h);
2. Saturação mínima da oxi-hemoglobina (**82%**);
3. Latência para o início do sono (**95,5 min**) (VN= 5 a 30 min);
4. Latência para o início do sono REM (**81,0 min**) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono (**64,5 %**) (VN= ≥ 85%);
6. Índice de despertares **5,8 nº/h** (VN= até 15 nº/h);
7. Percentual do estágio N1 (**3,6 %**) (VN= 2% a 5%);
8. Percentual do estágio N2 (**55,0 %**) (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta (**11,8 %**) (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM (**29,6 %**) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco verificado via sensor de ronco;

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

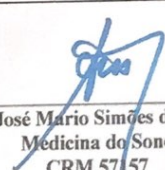
Exame evidenciando índice de distúrbio respiratório de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

DADOS DO PACIENTE:

Nome: JEAN HENRIQUE ESCUDERO PRINCE DA SILVA
ID: 0
Altura: 1,72 m
Peso: 98 kg
Sexo: Masculino
Data de Nascimento: 5-11-1992
IMC: 33,13

DADOS DO EXAME:

Hora do Exame: 22:11:09
Data do Exame: 20-12-2025
Médico Solicitante: DR. ENIO NAKUHIRO KOKUBU

Análise do Sono

Data/Horário de Início:	20/12/2025 22:11
Data/Horário de Término:	21/12/2025 05:44
Tempo Total de Registro (TTR):	453,2
Tempo Total de Sono (TTS):	292,5
Latência para o início do sono:	95,5
Latência para o sono REM:	81,0
Tempo acordado após o adormecer:	65,2
Eficiência do Sono (TTS/TTR x 100):	64,5 %

Estágios do Sono

	N1	N2	N3	REM	Vigília
Minutos	10,5	161,0	34,5	86,5	161,0
% de TTS	3,6	55,0	11,8	29,6	35,5

Despertares		
	Número	Índice (nº/h)
Total de despertares	44	5,8

Frequência Cardíaca		
	Média [bpm]	Máx [bpm]
REM	74,2	105
NREM	75,8	107
Vigília	83,8	110

Apneias/Hipopneias/RERAs								
	Apneias			Apneias (A)	Hipopneias (H)	A + H	"RERA"	A + H + "RERA"
	Central	Obstrutiva	Mista					
Número	0	34	0	34	161	195	0	195
Índice	0,0	7,0	0,0	7,0	33,0	40,0	0,0	40,0
Índice em REM	0,0	2,8	0,0	2,8	29,8	32,6	0,0	32,6
Índice em NREM	0,0	8,7	0,0	8,7	34,4	43,1	0,0	43,1
Duração máx (seg)	0	32,6	0	32,6	52,4	52,4	0	52,4
Duração média (seg)	0	14,3	0	14,3	22,4	18,3	0	18,3
Índice em Supino	0	0	0	0	0	0	0	0
Índice em Não Supino	0,0	7,0	0,0	7,0	33,0	40,0	0,0	40,0

- Apneia = queda de 90% do fluxo medido pelo termistor, com duração ≥ 10 segundos;
- Hipopneia = queda de 30% do fluxo medido pela cânula de pressão associada à dessaturação de 3% e/ou associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos;
- RERA (Respiratory effort related arousals) = achatamento da curva de fluxo aéreo indicado pela cânula de pressão associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos.

Índice de apneia + hipopneia: 40,0 (nº/h)

Índice de distúrbio respiratório (IDR = Apneia + Hipopneia + "RERA"): 40,0 (nº/h)